漢彌頓憂鬱量表(附結構式面談指南)

Hamilton Depression Rating Scale with Structured Interview Guide

概述:我想請教您有關過去一個禮拜的一些問題。從上個星期 (幾) 到現在,您覺得怎麼樣？

一、鬱悶情緒：悲傷、無望、無助、沒有價值（Depressed mood）

- 過去這個禮拜以來,您的情緒如何?
- 您曾經覺得情緒低落或憂鬱? 悲傷?無助感?
- 您是否經常有這種感覺?每天?整天? (若為是,則要問:您有這種感覺已經多久了?)
- 你曾哭過嗎?

0- 沒有
1- 只在詢問到時才說出這些感覺.
2- 自發地以的言語表達這些感覺.
3- 以非口頭方式來表達這些感覺，如面部表情、聲音、想哭的樣子.
4- 自發性的口頭及非口頭方式表達.

二、罪惡感：愧疚感受（Feeling of Guilt）

- 這個禮拜有沒有覺得自己一直做錯事,讓別人失望? （如果是:是什麼情形.）
- 您是否對所做過或未做過的事,覺得有罪惡感?
- 您是否覺得您遭到病魔的懲罰?

0- 沒有
1- 自責,覺得拖累別人
2- 有愧疚,罪惡感,反覆念及過去之過錯或罪行,有罪惡感
3- 認為目前的疾病是一種懲罰,有罪惡的幻想
4- 有被責備或痛罵的聽幻覺和／或幻想有威脅性的視幻覺

三、自殺（Suicide）

- 過去這個禮拜,您有沒有想過不值得再活下去,或者生不如死的念頭?有沒有想過自殘或甚至自殺?（如果是:想到什麼樣的情況?有沒有曾經確實傷害過自己?）

0- 沒有
1- 覺得活著沒有意思
2- 有,希望死了算了,或有自己可能要死的想法
3- 自殺念頭或做勢自殺
4- 企圖自殺,有自殺行為

四、失眠症：早期型（Insomnia-Early）

- 過去一週來,您的睡眠情形如何?
- 有沒有在開始睡覺時,難以入眠的情形? (上床後,多久才睡得著?)
- 這個禮拜以內有幾個夜晚睡不著?

0- 入眠不困難
1- 偶而有不能入眠的現象-即須半小時以上才能入眠
2- 抱怨晚上不能入眠

五、失眠症：中期型（Insomnia-Middle）

- 過去一個禮拜,有沒有在半夜醒來的情形?如果有,有沒有下床?做什麼?是不是只上廁所.
- 當您在躺下來時能不能馬上再入眠?您覺得有幾個晚上睡得很不安穩?

0- 沒有困難
1- 抱怨晚上睡得不安穩
2- 半夜會醒來,而深感困擾（除了上廁所外,只要半夜離床便評為 2）

六、失眠症：晚期型 (Insomnia-Late):

- 過去這個禮拜,你早上幾點醒來?
- 如果很早,是否因為用鬧鐘,或者是您自己醒來?
- 以前您通常幾點醒來(也就是,在您未發病前)

0- 沒有困難
1- 早上很早醒來,但又能再度入睡,有些困擾
2- 一醒來後(如果下床),就不能再入睡

七、工作及活動（Work and Activities）

- 過去這個星期中,您工作之餘,都做些什麼?
- 您做這些事情時,有沒有興趣,或者只是覺得是在逼自己做?
- 有沒有停止過您平時經常做的事?
- 您對未來有沒有什麼期盼?

0- 沒有困難
1- 對活動、工作或嗜好,會產生無力, 疲倦或衰弱的想法及感覺.
2- 自述對活動、嗜好、工作喪失興趣、或間接由病患的無精打采、優柔寡斷及游移不定看出來(覺得他必須強迫自己工作或從事活動).
3- 花在活動的實際時間減少或工作量降低,在住院期間,病患花在活動的時間,一天不超過三小時(活動指的是醫院的工作嗜好,不包括病房內的雜務或基本活動).
4- 因目前的疾病而停止工作,在住院期間,除病房內的雜務與基本活動外,沒有任何其他活動.或者,如果沒有人幫忙,甚至連病房雜務,基本活動也沒有辦法做.

八、遲滯現象：思考及語言遲緩、不能專心或活動量少（Retardation）- 根據面談時的觀察評分.

0- 說話及思考正常
1- 面談時有些許遲滯
2- 面談時有明顯遲滯現象
3- 面談難以進行
4- 完全靜呆無法會談

九、焦躁（Agitation）- 根據面談時的觀察評分.

0- 沒有
1- 不安
2- 玩弄手、頭髮等
3- 動來動去,坐不下
4- 扭絞痛自己的手,咬手指甲,拉扯頭髮,咬嘴唇

十、焦慮：精神層面（Anxiety-Psychic）

- 過去這個禮拜,有沒有特別覺得緊張或不安?
- 您是否對芝麻小事都擔心,或平常並不擔心的事,現在也擔心起來?如果是:請舉例?

0- 沒有困難
1- 自覺緊張或容易生氣
2- 芝麻小事也擔心
3- 面部表情或談話中有不安的狀態
4- 不用詢問,就表現出害怕的樣子

十一、 焦慮：焦慮所引發之生理併發症（Anxiety-somatic）

- 在過去這個禮拜,有沒有這些生理症狀?(唸右表的症狀,每唸六項就停頓一下,等對方回答)：焦慮會伴有的生理症狀,例如:腸胃方面-口乾、脹氣、消化不良、腹瀉、腹絞痛、打嗝,心臟循環細統-心悸、有鬱悶現象以前?呼吸系統-換氣過度、嘆氣.其他-多汗頻尿、頭痛、冒汗
- 過去這個禮拜以來,這件事情讓您有多煩? (嚴重到什麼地步?影響時間多長?這種症狀出現幾次,持續多久?)
  註:若歸藥物引起,例如:口乾及Imipramine就不要評分.

0- 沒有
1- 些微(詢問時才提出)
2- 中度會抱怨症狀
3- 嚴重(要求檢查、治療、反覆提出)
4- 無法工作,正常生活

十二、 身體症狀：腸胃方面（Somatic Symptoms-Gastrointestinal）

- 過去這個禮拜,您的胃口好不好? (和平常胃口比較)
- 您是否覺得必須強迫自己去吃嗎?
- 是否須要別人來催您吃?

0- 沒有
1- 沒有胃口,不覺得餓,但不用他人鼓勵也會吃
2- 沒有他人督促則不願進食,要求通便劑或其他解決胃腸症狀的藥.

十三、 身體症狀：全身性（Somatic symptoms-General）

- 過去這個禮拜,您的精力如何?
- 是不是一直都很累?（這個星期您曾經覺得頭痛、背痛,及肌肉酸痛?）
- 這個星期以來您覺得背部、頭部或四肢很重嗎?

0- 沒有
1- 感覺四肢,背或頭沉重,有背痛、頭痛、肌肉酸痛、缺乏精力,易感到疲倦
2- 有很明顯的症狀

十四、 生殖系統的症狀：例如性欲喪失、月經失調（Genital Symptoms）

- 這一週來,您在性方面的興趣如何? (不是實際性行為方面,而是對性方面的興趣-您有沒有想過?想的程度如何?)
- 您在性方面的興趣,有沒有什麼改變(和沒有憂鬱時比較起來如何)?你會不會擔心呢?如果不會,那對您來說那種情形,是不是不尋常?

0- 沒有
1- 一點點
2- 嚴重

十五、 慮病現象（Hypochondriasis）

- 過去這個禮拜,有沒有特別注意自己的身體健康,或身體如何(與平常比較)?
- 您是否比平常更覺得身體不健康,發現自己要求別人幫助您以前能做的事?如果有:舉例?次數?

0- 沒有
1- 過份專注自己的身體
2- 一直顧慮健康
3- 經常抱怨不適
4- 慮病妄想

十六、 體重減輕（Loss of weight）（選 A 或 B）

- 自從這次(憂鬱)開始以來,有沒有減輕體重的情形? （若是減輕多少?）
- 若不確定:您是不是覺得衣服寬鬆許多?體重有沒有回升?

A. 按病史評定

0- 體重沒有減輕
1- 可能有因目前的疾病而減輕體重之現象
2- (根據病患) 確時有體重減輕情形

B. 根據實際量體重結果,由病房護士每週測量

0- 每週減輕 0.5 公斤以內
1- 每週減輕 0.5 公斤以上
2- 每週減輕 1 公斤以上

十七、 病識感（Insight）- 根據觀察評分

0- 確知自己有憂鬱症及有病,或目前實際不憂鬱
1- 確知自己有病,但歸因於飲食不良、氣候、工作勞累者,需休息等等
2- 完全否認自己有病

十八、 日間變化（Diurnal variation）- 午前較差.

0- 沒有
1- 些微(差異度輕微, 僅情緒上的感覺)
2- 嚴重(差異度大, 會影響日常生活的表現)

十九、 自我感或現實感消失（Depersonalization and derealization）

0- 沒有
1- 輕微, 只在詢問到時才說出這些感覺.
2- 中度, 自發地以的言語表達這些感覺, 但仍懷疑是否為真.
3- 重度, 自發地以的言語表達這些感覺, 但仍確信是否為真.
4- 嚴重, 會影響日常生活及行為.

二十、 妄想症狀（Paranoid symptoms）

0- 沒有
1- 輕微, 自以為不可能但仍會想.
2- 中度, 自以為可能但不確定.
3- 關係妄想.
4- 關係及被害妄想.

二十一、強迫意念和強迫行為（Obsessional and compulsive symptoms）

0- 沒有
1- 輕微, 不會影響日常生活及行為.
2- 嚴重, 會影響日常生活及行為.